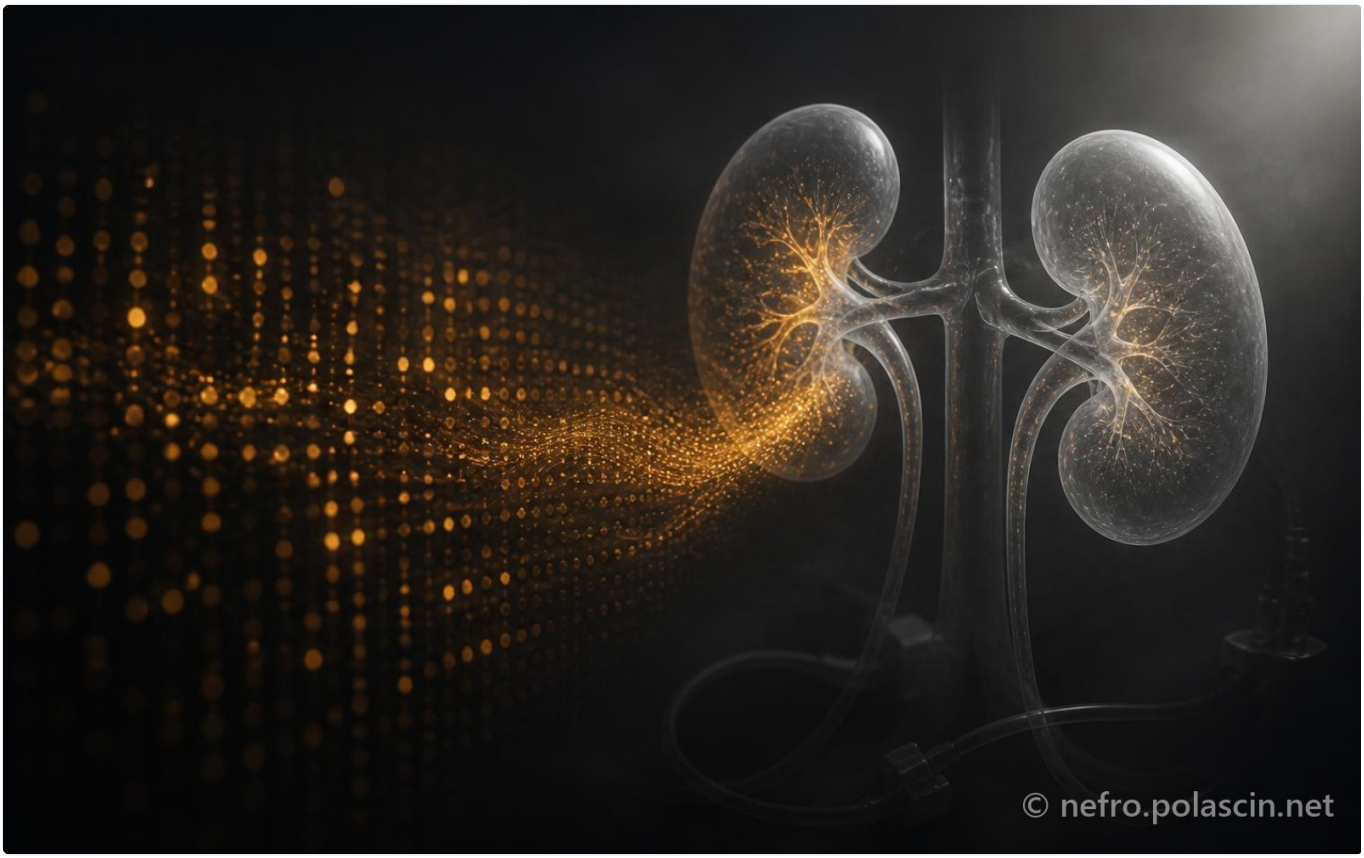
Dialyzačná liečba na Slovensku podľa údajov NCZI za rok 2025: čo z nich vyplýva a čo nie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná, poloschematická scéna – nejde o snímku konkrétneho pacienta ani o zobrazenie reálneho pracoviska. Celoštátny register vidí počty; jednotlivého pacienta za nimi nevidí.

Súhrnné celoštátne údaje sú cenné práve tým, čo o systéme povedia – a zavádzajúce práve tým, čo sa z nich povedať nedá. Správa Národného centra zdravotníckych informácií za rok 2025 prináša prvý medziročný pokles počtu dialyzovaných pacientov po dlhodobo rastúcom trende, veľmi nízky podiel peritoneálnej dialýzy a najnižší počet transplantácií obličky od roku 2021. Žiadny z týchto údajov sa však sám osebe nedá čítať ako hodnotenie kvality starostlivosti.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo v auguste 2026 súhrnnú správu *Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2025*. Zdrojom sú ročné výkazy o činnosti nefrologickej ambulancie (A [MZ SR] 13-01) a o činnosti stacionára v odbore nefrológia (T [MZ SR] 2-01).

Výstup za rok 2025 nahrádza údaje za rok 2024, ktoré NCZI publikovalo v novembri 2025 a sprevádzalo tlačovou správou z 3. decembra 2025 s titulkom o tom, že dialýzu potrebuje čoraz viac seniorov. Tento článok vychádza z oboch výstupov, pretože až ich porovnanie ukazuje, ktoré závery sú stabilné a ktoré boli platné iba pre jeden rok.

Čo ukazujú najnovšie celoštátne údaje

Ukazovateľ	2024	2025
Dialyzačné stacionáre, ktoré vykázali činnosť	75	72
Lôžka pre pacientov vo veku 19 rokov a viac	999	962

Ukazovateľ	2024	2025
Pacienti v pravidelnej dialyzačnej liečbe (PDL)	4 445	4 352
Pacienti v PDL na 100 000 obyvateľov	82,0	80,5
Liečení hemodialýzou k 31. 12.	3 319	3 330
Liečení peritoneálnou dialýzou k 31. 12.	94	103
Osoby na transplantačnej čakacej listine k 31. 12.	372	348
Transplantácie obličky	140	118
Evidované úmrtia osôb liečených v PDL	595	548
Osoby s CKD v 5. štádiu v nefrologických ambulanciách, nezaradené do PDL	1 529	1 500

Každý riadok tejto tabuľky má inú metodickú povahu. Počet pacientov v PDL je prevalenčný údaj za celý rok. Počty liečených hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou sú stavy k 31. decembru. Počet transplantácií je ročný tok. Osoby na čakacej listine sú stav k jednému dňu. Tieto ukazovatele **nemožno navzájom deliť ani sčítavať** bez toho, aby sme si uvedomili, že ide o rôzne typy veličín.

Názorne to ukazuje samotná správa. K 31. decembru 2025 bolo hemodialýzou liečených 3 330 a peritoneálnou dialýzou 103 pacientov, spolu teda 3 433 osôb. Za celý rok však bolo v PDL evidovaných 4 352 pacientov. Rozdiel nie je chybou – vyjadruje, že počas roka časť pacientov zomrela, podstúpila transplantáciu alebo z programu odišla z iných dôvodov.

Medziročný pokles neznamená, že zlyhania obličiek ubúda

Miera pacientov v PDL klesla z 82,0 na 80,5 prípadu na 100 000 obyvateľov, teda o 1,2 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 93 osôb. Ide o prvý pokles po období, ktoré NCZI dlhodobo opisovalo ako rastúce; od roku 2009 miera stúpla o 11 %.

Pokles o 1,2 % v jedinom roku **nie je dôkazom obratu trendu**. Prevalencia dialyzovaných pacientov je výsledkom rovnováhy medzi prítokom a odtokom. Zvýšiť ju môže vyšší výskyt zlyhania obličiek alebo dlhšie prežívanie; znížiť ju môže viac transplantácií, vyššia úmrtnosť, menej nových pacientov, ale aj zmena vo vykazovaní.

Práve posledná možnosť si zaslúži pozornosť. Počet stacionárov, ktoré vykázali činnosť, klesol zo 75 na 72 a počet lôžok z 999 na 962. Správa za rok 2025 navyše uvádza, že na začiatku roka bolo hemodialýzou liečených 3 172 pacientov, hoci podľa správy za rok 2024 ich na konci predchádzajúceho roka bolo 3 319. Takýto nesúlad medzi koncom jedného a začiatkom nasledujúceho roka ukazuje, že časť medziročnej zmeny môže vzniknúť na úrovni vykazujúcich pracovísk, nie v epidemiológii.

Zodpovedný záver preto znie: miera dialyzovaných pacientov v roku 2025 mierne klesla, dlhodobý trend zostáva rastúci a na posúdenie, či ide o začiatok zmeny, bude potrebných viac rokov a stabilné vykazovanie.

Diabetes a cievne poškodenie obličiek dominujú diagnostickej štruktúre

Podľa vykazovanej základnej diagnózy tvorili v roku 2025 pacienti v PDL:

- **34,8 %** glomerulová choroba pri diabetes mellitus, teda diabetická nefropatia (N08.3) – 1 513 osôb,
- **15,2 %** hypertenzná a vaskulárna nefroskleróza (I12 – I13, I70.1, N28.0) – 661 osôb,
- **15,1 %** tubulointersticiálne nefritídy (N10 – N16) – 657 osôb,
- **11,7 %** primárne (N00 – N06) a hereditárne (N07) glomerulové choroby – 510 osôb,
- **6,0 %** sekundárne glomerulové choroby okrem diabetu, **5,5 %** polycystické obličky a **3,3 %** nešpecifikovaná choroba obličiek.

Rozloženie je medziročne takmer nezmenené (v roku 2024 to bolo 34,8 %, 15,8 %, 15,0 % a 12,4 %). Diagnostická štruktúra dialyzovanej populácie je teda stabilná a dominuje jej metabolické a cievne poškodenie obličiek.

Tieto podiely však **nevyjadrujú riziko**, že konkrétny človek s diabetom alebo hypertenziou bude potrebovať dialýzu. Opisujú zloženie dialyzovanej populácie, nie pravdepodobnosť progresie. Na takéto hodnotenie by boli potrebné údaje o všetkých osobách s danou chorobou a o ich dlhodobom sledovaní.

Užitočné je porovnanie s ambulantnou nefrologickou starostlivosťou, kde bolo v roku 2025 sledovaných 149 527 osôb. Tam tvorila diabetická nefropatia iba 20,1 % a tubulointersticiálne nefritídy 18,8 %. Diabetické poškodenie obličiek je teda v dialyzačnej populácii zastúpené **takmer dvojnásobne** oproti ambulantnej. To je zlučiteľné s vyššou pravdepodobnosťou progresie do zlyhania obličiek, no samo osebe to nedokazuje – rovnaký obraz by mohol vzniknúť aj rozdielnym prežívaním alebo rozdielnou dostupnosťou transplantácie.

Pri diabete treba navyše dôsledne rozlišovať štatistickú kategóriu, klinickú diagnózu a histologický nález. Označenie „glomerulová choroba pri diabetes mellitus“ je prevzaté z vykazovania a nie je dôkazom, že u každého takto zaradeného pacienta bolo diabetické poškodenie potvrdené biopsiou. Nie každá chronická choroba obličiek u človeka s diabetom je spôsobená diabetom.

Podobne hypertenzia môže k poškodeniu obličiek prispievať, ale môže byť aj jeho dôsledkom. Súhrnná štatistika tieto vzťahy nerozlišuje.

Vek mení potreby pacienta, nie je však kritériom rozhodovania

Potreba dialyzačnej liečby rastie s vekom veľmi výrazne. Vekovo špecifické miery za rok 2025 to ukazujú lepšie ako samotné poradie skupín:

Veková skupina	2024 (na 100 000 obyvateľov daného veku)	2025 (na 100 000 obyvateľov daného veku)
70 rokov a viac	268,6	257,2
60 – 69 rokov	176,6	168,9
50 – 59 rokov	97,4	94,7
40 – 49 rokov	44,7	44,0
30 – 39 rokov	28,0	27,7
19 – 29 rokov	12,8	13,1
Slovenská republika spolu	82,0	80,5

Medzi skupinou 19 – 29 rokov a skupinou 70 rokov a viac je rozdiel takmer dvadsaťnásobný. Vekovo špecifické miery zároveň ukazujú, že medziročný pokles celkovej miery nebol rovnomerný: v najstarších skupinách klesla výraznejšie, v skupine 19 – 29 rokov naopak mierne stúpla.

Prevaha starších pacientov má praktické dôsledky pre organizáciu starostlivosti. U nich je potrebné venovať väčšiu pozornosť funkčnej zdatnosti, krehkosti, výžive, kognitívnym schopnostiam, riziku pádov, dostupnosti pomoci v domácnosti a záťaži spojenej s dopravou na pracovisko a zotavením po procedúre.

Kalendárny vek však **nie je dostatočným podkladom** na rozhodnutie o začatí, pokračovaní či spôsobe dialýzy. Klasická práca Kurella Tamura a spolupracovníkov na 3 702 obyvateľoch amerických zariadení dlhodobej starostlivosti ukázala, že dvanásť mesiacov po začatí dialýzy bolo 58 % z nich mŕtvych a predialyzačnú funkčnú zdatnosť si zachovalo iba 13 %. Táto populácia je mimoriadne krehká a výsledky nemožno zovšeobecňovať na všetkých starších pacientov – práve preto je ich odkazom individuálne posúdenie, nie vekový limit.

Modalita: hemodialýza takmer bez alternatívy

Správa za rok 2025 umožňuje spoľahlivo posúdiť zastúpenie dialyzačných metód. K 31. decembru 2025 bolo hemodialýzou liečených 3 330 pacientov (2 078 mužov a 1 252 žien) a peritoneálnou dialýzou 103 pacientov. Peritoneálna dialýza teda tvorila **približne 3 % dialyzovanej populácie** (v roku 2024 približne 2,8 %).

Pre porovnanie: podľa výročnej správy registra Európskej renálnej asociácie (ERA) za rok 2022, ktorá pokrývala

530 miliónov obyvateľov z 35 krajín, tvorila peritoneálna dialýza 5 % všetkých pacientov liečených náhradou funkcie obličiek a hemodialýza 56 %. Prepočítané na samotnú dialyzovanú populáciu ide o približne **8 % peritoneálnej dialýzy**, teda zhruba dvaapolnásobok slovenského podielu.

Regionálne rozdiely sú ešte výraznejšie než celoštátny priemer. V Bratislavskom kraji bolo ku koncu roka 2025 peritoneálnou dialýzou liečených 22 pacientov a v Banskobystrickom 27, zatiaľ čo v Trnavskom kraji 2 a v Prešovskom kraji NCZI neuvádza žiadneho. Z celkových 103 pacientov bolo 81 liečených automatizovanou a 41 kontinuálnou ambulantnou peritoneálnou dialýzou (pacient, u ktorého boli použité oba typy, je započítaný v oboch skupinách).

Tieto čísla samy osebe nehovoria, prečo je podiel domácej metódy taký nízky. Prispievať môže zloženie pacientov, dostupnosť predialyzačnej edukácie, personálne a technické zabezpečenie pracovísk, spôsob úhrady aj preferencie pacientov. Údaje však ukazujú, kde by sa dal priestor na zmenu hľadať – a že ten priestor nie je rozložený rovnomerne po krajoch.

Pozoruhodný je aj údaj o type mimotelovej liečby. V roku 2025 bolo vykázaných 449 333 procedúr hemodiafiltrácie oproti 53 251 procedúram klasickej hemodialýzy; hemodiafiltrácia teda tvorila približne **89 % mimotelových eliminačných procedúr**. To je klinicky priaznivé zistenie: randomizovaná štúdia CONVINCE s 1 360 pacientmi preukázala, že vysokoobjemová hemodiafiltrácia znižuje celkovú úmrtnosť oproti konvenčnej vysokoprietokovej hemodialýze (17,3 % oproti 21,9 %; HR 0,77; 95 % IS 0,65 – 0,93).

Dôležitá výhrada: výkaz NCZI eviduje počty procedúr, **nie dosahovaný konvekčný objem**. Prínos preukázaný v štúdii CONVINCE bol viazaný na vysoký konvekčný objem (v priemere 25,3 litra na procedúru). Z počtu vykázaných procedúr hemodiafiltrácie preto nemožno usudzovať, že slovenskí pacienti dostávajú dávku porovnateľnú s tou, ktorá prínos preukázala.

Kategória G5 neznamená automatickú indikáciu dialýzy

V nefrologických ambulanciách bolo v roku 2025 evidovaných 1 500 osôb s chronickou chorobou obličiek v 5. štádiu, ktoré neboli zaradené do pravidelnej dialyzačnej liečby. Osobitne správa uvádza 664 pacientov s týmto ochorením zaradených do PDL.

Tieto dve hodnoty **nemožno interpretovať** tak, že 664 pacientov pochádzalo práve zo skupiny 1 500 osôb, a nemožno z nich počítať podiel tých, ktorí počas roka „prešli na dialýzu“.

Z klinického hľadiska kategória G5 podľa KDIGO označuje chronickú chorobu obličiek s odhadovanou glomerulovou filtráciou nižšou ako 15 ml/min/1,73 m². Sama osebe neurčuje deň začatia dialýzy. Rozhodujú prejavy zlyhania obličiek, zvládnuteľnosť porúch vnútorného prostredia a objemového stavu, výživový stav a celkový klinický kontext.

Randomizovaná štúdia IDEAL u 828 pacientov porovnávala plánované začatie dialýzy pri odhadovanej glomerulovej filtrácii 10 – 14 ml/min oproti 5 – 7 ml/min. Po mediáne sledovania 3,59 roka sa úmrtnosť medzi skupinami nelíšila (37,6 % oproti 36,6 %; HR 1,04; 95 % IS 0,83 – 1,30), rovnako ani výskyt kardiovaskulárnych príhod, infekcií a komplikácií dialýzy. Pozoruhodné je, že 75,9 % pacientov v skupine s neskorým začatím začalo dialýzu skôr, než klesli na cieľovú hodnotu – pre rozvoj príznakov. Práve to podporuje záver, že o načasovaní má rozhodovať klinický stav, nie prahová hodnota filtrácie.

Medzi naliehavé dôvody na začatie dialyzačnej liečby patria nezvládnuteľná hyperkaliémia, metabolická acidóza, prevodnenie a uremické komplikácie. Naliehavosť sa posudzuje individuálne a nemožno ju určiť z jednej hodnoty kreatinínu ani z odhadovanej glomerulovej filtrácie.

Nezaradenie pacienta s kategóriou G5 do PDL preto samo osebe **nepreukazuje zanedbanie ani nedostupnosť starostlivosti**. Môže ísť o klinicky odôvodnené sledovanie, prípravu na náhradu funkcie obličiek alebo o individuálne zvolenú komplexnú konzervatívnu starostlivosť. Systematický prehľad jedenástich štúdií porovnávajúcich konzervatívny a dialyzačný postup u pacientov s 5. štádiom CKD – prevažne u starších osôb – nezistil prevahu dialýzy v prežívaní, hospitalizáciách ani kvalite života. Prehľad je metodicky obmedzený prevahou observačných štúdií a výberovým skreslením a jeho výsledky nemožno zovšeobecniť na mladších pacientov, upozorňuje však, že nezaradenie do dialýzy nie je automaticky horšou alternatívou. Súhrnné údaje NCZI tieto situácie nerozlišujú.

Transplantácia obličky nie je podmienená predchádzajúcou dialýzou

Ku koncu roka 2025 bolo na transplantačnej čakacej listine 348 osôb a v priebehu roka podstúpilo transplantáciu obličky 118 pacientov. Oproti roku 2024 (372 osôb a 140 transplantácií) ide o pokles v oboch ukazovateľoch a o najnižší počet transplantácií od roku 2021.

Tu je namieste **vecná oprava formulácie samotného zdroja**. Správa NCZI uvádza, že transplantácia obličky sa vykonáva u pacientov, ktorí pravidelne podstupujú dialyzačnú liečbu, a že podmienkou je „dobrý zdravotný stav pacienta“. Obe formulácie sú zjednodušujúce.

Transplantácia obličky nie je vyhradená pacientom, ktorí už dialýzu podstupujú. U vhodného kandidáta možno vykonať **preemptívnu transplantáciu**, teda transplantáciu pred začatím pravidelnej dialyzačnej liečby. Nejde o okrajovú možnosť: podľa registra ERA tvorila preemptívna transplantácia v roku 2022 **5 % všetkých začatí náhrady funkcie obličiek** v sledovaných európskych krajinách. Rozsiahla analýza 38 836 prvých transplantácií obličky zistila, že preemptívna transplantácia bola spojená s nižším rizikom zlyhania štepu (relatívne riziko 0,75 pri darcovi po smrti a 0,73 pri žijúcom darcovi) aj s nižším rizikom úmrtia (0,84, resp. 0,69). Ide o observačné údaje, pri ktorých nemožno vylúčiť, že preemptívne transplantovaní pacienti boli vybranejšou skupinou.

Ani transplantačnú spôsobilosť nemožno zúžiť na „dobrý zdravotný stav“. Odporúčanie KDIGO z roku 2020 ju definuje ako odborné posúdenie pomeru prínosu a rizika, imunologických a psychosociálnych faktorov, jednotlivých komorbidít a možnosti dlhodobej potransplantačnej starostlivosti – pričom každý rizikový faktor sa posudzuje samostatne a výsledkom je celkový úsudok, nie splnenie jedinej podmienky.

Pomer 348 čakajúcich k 4 352 dialyzovaným **nemožno interpretovať** ako podiel pacientov, ktorým bola transplantácia neoprávnene odopretá. Na posúdenie dostupnosti transplantácie sú potrebné údaje o spôsobilosti, odosielaní na vyšetrenie, dôvodoch nezaradenia a čase strávenom na čakacej listine.

Určitý kontext predsa len poskytnúť možno. Pri počte obyvateľov 5 409 407 k 31. decembru 2025 zodpovedá 118 transplantácií približne 21,8 výkonu na milión obyvateľov; v roku 2024 to bolo približne 25,8. Register ERA uvádza za rok 2022 priemernú mieru transplantácií 40 na milión obyvateľov. Ide o hrubé, vekovo neštandardizované porovnanie s inou metodikou aj iným rokom a slovenský údaj navyše zahŕňa iba transplantácie u pacientov z vlastného dialyzačného stacionára. Ani s týmito výhradami nejde o rozdiel, ktorý by sa dal prehliadnuť.

Čo možno a nemožno povedať o úmrtnosti

V roku 2025 bolo evidovaných 548 úmrtí osôb liečených v PDL. NCZI tento počet vzťahuje na prevalenčnú populáciu a uvádza približne 13 úmrtí na 100 pacientov v PDL.

Príčina úmrtia	2024	2025
Kardiovaskulárne choroby	332	286
Infekčné choroby	124	142
Malignity	88	68
„Dialyzačná kachexia“	27	24
Úmrtia spolu	595	548

Kardiovaskulárne príčiny zostávajú najčastejšie, ich absolútny počet však klesol z 332 na 286, zatiaľ čo počet úmrtí na infekčné choroby stúpol zo 124 na 142. Jednoročná zmena pri takýchto počtoch môže byť náhodná a nemožno ju bez ďalšej analýzy vykladať ako zmenu rizikového profilu dialyzovanej populácie.

Označenie **„dialyzačná kachexia“** treba chápať ako termín použitý vo výkaze. Nezodpovedá zavedenej odbornej terminológii. Expertný panel Medzinárodnej spoločnosti pre renálnu výživu a metabolizmus odporúča pre stratu telesnej bielkovinovej hmoty a energetických zásob pri chorobe obličiek termín **proteínovo-energetické chradnutie** a kachexiu vyhradzuje pre jeho najťažšiu, zriedkavú formu. Bez definície vykazovanej kategórie nemožno 24 úmrtí stotožniť s počtom pacientov s proteínovo-energetickým chradnutím ani ich čítať ako dôkaz, že príčinou úmrtia bola samotná dialýza.

Jednoduché vydelenie 548 úmrtí počtom 4 352 pacientov (12,6 %) **neposkytuje spoľahlivý odhad ročnej**

mortality. Počas roka pacienti do programu vstupujú, podstupujú transplantáciu, zomierajú alebo z neho odchádzajú z iných dôvodov; korektný výpočet vyžaduje populáciu v riziku a čas sledovania.

Podrobnejšie údaje o pohybe pacientov to dokladajú. V roku 2025 bolo do PDL prijatých 151 pacientov dovtedy nesledovaných pre zlyhanie obličiek, 534 z vlastnej nefrologickej ambulancie, 149 z inej nefrologickej ambulancie a 265 z iných dôvodov; prepustených bolo 548 pre úmrtie, 114 pre transplantáciu a 257 pre preradenie do iného stacionára. Pacienti teda do sledovanej populácie vstupovali a z nej vystupovali v priebehu celého roka.

Dvojica čísel si tu zaslúži osobitnú poznámku: správa uvádza 118 transplantovaných pacientov, no zároveň 114 pacientov prepustených z PDL pre transplantáciu. Nejde o protirečenie, ale o dva rôzne ukazovatele z dvoch rôznych výkazových tabuliek. Je to presne ten typ rozdielu, ktorý pri nekritickom spájaní čísel vedie k nesprávnym výpočtom.

Osobitnú pozornosť si zaslúži skupina 151 pacientov prijatých bez predchádzajúceho sledovania pre zlyhanie obličiek. Zo 834 pacientov prijatých buď z nefrologickej ambulancie, alebo bez nej, ide približne o 18 %. Neplánovaný začiatok dialýzy je vo všeobecnosti spojený s horšími výsledkami, nižším podielom natívnych cievnych prístupov a menšou možnosťou voľby modality. Samotný výkaz však neuvádza, či išlo o neskorý záchyt, o akútny priebeh alebo o pacientov sledovaných inde, a nemožno z neho tieto situácie rozlíšiť.

Zaujímavý je aj vzťah medzi dĺžkou dialyzačnej liečby a úmrtnosťou. Najpočetnejšiu skupinu tvorili pacienti liečení kratšie ako jeden rok (1 716 osôb), z ktorých počas roka zomrelo 192, teda 11,2 %. Najvyššia úmrtnosť bola v skupine liečenej 15 a viac rokov (14,7 %) a v skupine 6 až 10 rokov (14,6 %). Ani tieto podiely nie sú ročnou mortalitou v epidemiologickom zmysle: súčet pacientov vo všetkých skupinách (4 734) prevyšuje počet pacientov v PDL (4 352), pretože zahŕňa aj osoby dialyzované kratšie ako 90 dní, ktoré do PDL zaradené neboli.

Z celoštátneho počtu úmrtí napokon **nemožno porovnávať kvalitu jednotlivých pracovísk**. Takéto porovnanie vyžaduje zohľadniť vek, komorbidity, krehkosť, spôsob začatia dialýzy a ďalšie prognostické faktory.

Limity a čo v údajoch chýba

Správa NCZI je administratívnym výkazovým zberom, nie klinickým registrom. Z toho vyplývajú jej hlavné obmedzenia:

- základná diagnóza je vykazovaná, nie overená biopsiou ani jednotnou klinickou definíciou,
- nie sú dostupné údaje o cievnych prístupoch, dialyzačnej dávke, konvekčnom objeme ani o reziduálnej funkcii obličiek,
- chýbajú údaje o plánovanom oproti neplánovanému začatiu liečby, o hospitalizáciách a o infekčných komplikáciách,
- chýbajú údaje o počte žijúcich príjemcov štepu, takže nemožno vypočítať celkovú prevalenciu náhrady funkcie obličiek ani ju porovnať s európskym priemerom 1 074 pacientov na milión obyvateľov,
- chýbajú údaje o kvalite života, o záťaži spojenej s dochádzaním a o preferenciách pacientov,
- návratnosť výkazov a počet vykazujúcich pracovísk sa medzi rokmi mení, čo ovplyvňuje porovnateľnosť.

Pre slovenskú nefrológiu z toho vyplývajú dva praktické odkazy. Prvým je, že údaje podporujú prepájanie prevencie progresie chronickej choroby obličiek, včasnej predialyzačnej edukácie, plánovania cievneho prístupu, transplantačného vyšetrenia a dlhodobej multidisciplinárnej starostlivosti. Druhým je, že na hodnotenie kvality starostlivosti súčasný výkazový zber nestačí – a že nízky podiel peritoneálnej dialýzy a klesajúci počet transplantácií sú práve tie oblasti, kde by podrobnejšie údaje priniesli najväčší úžitok.

Článok je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické posúdenie, odborné nefrologické vyšetrenie ani aktuálne odporúčané postupy. Rozhodnutie o začatí, modalite a pokračovaní liečby nahrádzajúcej funkciu obličiek je vždy individuálne.

Súvisiace články

- Preemptívna transplantácia – transplantácia pred začatím dialýzy.

- Zaradenie do transplantačného programu – ako sa posudzuje spôsobilosť.
- Predialyzačná edukácia a voľba peritoneálnej dialýzy – predpoklad vyššieho podielu domácej liečby.
- Dialyzačná modalita a prežívanie oktogenárov – peritoneálna dialýza oproti hemodialýze u najstarších pacientov.
- Vysokoobjemová hemodiafiltrácia a mortalita – prečo záleží na konvekčnom objeme, nie na názve metódy.
- Paliatívna starostlivosť v nefrológii – komplexná konzervatívna starostlivosť u krehkých starších pacientov.
- Klinická krehkosť a mortalita na dialýze – prečo kalendárny vek nestačí.

Zdroje

1. **Národné centrum zdravotníckych informácií.** *Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2025.* Bratislava: NCZI; publikované august 2026. Inštitucionálny autor, individuálni autori neuvedení. Správa k publikovaným výstupom (PDF); tabuľkové výstupy (XLSX).
2. **Národné centrum zdravotníckych informácií.** *Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2024.* Bratislava: NCZI; publikované november 2025. Správa (PDF); prehľad výstupov v odbore nefrológia .
3. **Národné centrum zdravotníckych informácií.** *Dialýzu potrebuje čoraz viac seniorov, najčastejším dôvodom je cukrovka.* Tlačová správa, 3. decembra 2025. Text správy.
4. **Rianne Boenink, Marjolein Bonthuis, Brittany A. Boerstra, Megan E. Astley, Iris R. Montez de Sousa a spol. (ERA Registry).** *The ERA Registry Annual Report 2022: Epidemiology of Kidney Replacement Therapy in Europe, with a focus on sex comparisons.* Clinical Kidney Journal. 2025;18(2):sfae405. DOI. Korigendum: Clinical Kidney Journal. 2025;18(5):sfaf107, DOI.
5. **Bruce A. Cooper, Pauline Branley, Liliana Bulfone, John F. Collins, Jonathan C. Craig a spol. (IDEAL).** *A Randomized, Controlled Trial of Early versus Late Initiation of Dialysis.* New England Journal of Medicine. 2010;363(7):609–619. DOI.
6. **Bertram L. Kasiske, Jon J. Snyder, Arthur J. Matas, Mary D. Ellison, John S. Gill, Annamaria T. Kausz.** *Preemptive Kidney Transplantation: The Advantage and the Advantaged.* Journal of the American Society of Nephrology. 2002;13(5):1358–1364. DOI.
7. **Steven J. Chadban, Curie Ahn, David A. Axelrod, Bethany J. Foster, Bertram L. Kasiske, Vijah Kher a spol. (KDIGO).** *KDIGO Clinical Practice Guideline on the Evaluation and Management of Candidates for Kidney Transplantation.* Transplantation. 2020;104(4S1 Suppl 1):S11–S103. DOI.
8. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney International. 2024;105(4S):S117–S314. DOI.
9. **Peter J. Blankestijn, Robin W. M. Vernooij, Carinna Hockham, Giovanni F. M. Strippoli, Bernard Canaud a spol. (CONVINCE).** *Effect of Hemodiafiltration or Hemodialysis on Mortality in Kidney Failure.* New England Journal of Medicine. 2023;389(8):700–709. DOI.
10. **D. Fouque, K. Kalantar-Zadeh, J. Kopple, N. Cano, P. Chauveau a spol. (ISRNM).** *A Proposed Nomenclature and Diagnostic Criteria for Protein-Energy Wasting in Acute and Chronic Kidney Disease.* Kidney International. 2008;73(4):391–398. DOI.
11. **Manjula Kurella Tamura, Kenneth E. Covinsky, Glenn M. Chertow, Kristine Yaffe, C. Seth Landefeld, Charles E. McCulloch.** *Functional Status of Elderly Adults before and after Initiation of Dialysis.* New England Journal of Medicine. 2009;361(16):1539–1547. DOI.
12. **Mario Pacilio, Roberto Minutolo, Carlo Garofalo, Maria Elena Liberti, Giuseppe Conte, Luca De Nicola.** *Stage 5-CKD under Nephrology Care: To Dialyze or Not to Dialyze, That Is the Question.* Journal of Nephrology. 2016;29(2):153–161. DOI.

Poznámka k dôkazom: *Všetky slovenské číselné údaje boli overené priamo proti primárnym výstupom NCZI, nie proti tlačovej správe: údaje za rok 2025 proti správe k publikovaným výstupom a proti tabuľkám T 7 (modality), T 8 (pohyb pacientov), T 12 (dĺžka liečby a úmrtia), T 15 (mimotelová eliminačná liečba), T 16 (typy*

peritoneálnej dialýzy), T 18 (čakacia listina a transplantácie) a prílohe s počtom obyvateľov; údaje za rok 2024 proti správe publikovanej v novembri 2025. Bibliografia zahraničných prác bola overená cez PubMed a Crossref (úplné autorské zoznamy, ročník, číslo, strany, DOI); číselné výsledky štúdií IDEAL a CONVINCE, práce Kasiskeho a spolupracovníkov, práce Kurella Tamura a spolupracovníkov, prehľadu Pacilia a spolupracovníkov a výročnej správy registra ERA pochádzajú z ich abstraktov. ***Rozdiely oproti pôvodnej predlohe:*** *predloha vychádzala z údajov za rok 2024 a z tlačovej správy NCZI; v čase prípravy tohto článku už boli zverejnené údaje za rok 2025, ktoré ukazujú medziročný pokles, nie rast, a ktoré obsahujú aj rozpis podľa dialyzačnej modality, pohybu pacientov a dĺžky liečby. Predloha uvádzala, že tieto údaje k dispozícii nie sú. Oprava zjednodušených formulácií zdroja o transplantácii, porovnanie s registrom ERA, prepočty na milión obyvateľov, terminologická korekcia pojmu „dialyzačná kachexia“ a prepojenie na klinické usmernenia a randomizované štúdie sú* ***vlastným odborným spracovaním****, nie závermi NCZI.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=dialyzacna-liecba-slovensko-nczi-2025 · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.